

MEDICAL PLATFORM

BUSINESS & DATA ANALYSIS REPORT

Executive analysis del report Power BI

Executive message

Il modello simulato rappresenta una piattaforma regionale di servizi medici nel Lazio. L'analisi evidenzia un business stabile, una forte concentrazione del valore su Roma e sulle specialità a maggiore ticket e soprattutto un'opportunità concreta di riduzione dei no-show attraverso una gestione più sistematica dei reminder.

Nome e Cognome	<i>Fabrizio Fagetti</i>
Ruolo	<i>Data Analyst</i>
Email	<i>fabriziofagetti@gmail.com</i>
LinkedIn	<i>linkedin.com/in/fabrizio-fagetti-7b5773154</i>
Repository GitHub	<i>github.com/Fabriscious/energy-transition-italy</i>
Video Introduttivo	<i>youtu.be/TkfvKTz7-CI</i>

Dataset sintetico • 3 anni • Regione Lazio • Power BI

Executive Summary

Il presente documento interpreta il report Power BI sviluppato per una piattaforma simulata di servizi medici operante nella Regione Lazio. Il progetto è stato costruito come esercitazione di Data Analysis end-to-end: generazione sintetica dei dati, modellazione relazionale, caricamento in MySQL, analisi SQL e costruzione di dashboard interattive in Power BI.

Indicatore	Valore	Lettura manageriale
Pazienti	50.000	Ampia base utenti simulata
Appuntamenti	300.000	Volume complessivo su tre anni
Visite completate	259.368	Prestazioni effettivamente completate, da SQL
Fatturato incassato	€25,41 M	Ricavi effettivamente pagati
Revenue media	€97,98	Media riferita alle visite effettivamente pagate
No-show rate	7%	Principale area di inefficienza
Reminder rate	75%	Leva già ampiamente utilizzata
Fatturato perso da no-show	€2,32 M	Potenziale valore da mitigare

Nota metodologica sul prezzo medio

Nel materiale Power BI compare anche €109,09 come prezzo medio visita. Questo valore rappresenta il valore medio della prestazione e non va confuso con €97,98, riferito alle visite effettivamente pagate. Nel documento i due KPI vengono quindi trattati separatamente.

1. Obiettivo e metodologia

Il report non descrive una società reale: i dati sono artificiali, ma progettati per mantenere coerenza interna tra pazienti, provider, strutture, appuntamenti, diagnosi, farmaci, fatturazione, laboratori e feedback. Il perimetro comprende 50.000 pazienti, 400 provider, 50 strutture e 300.000 appuntamenti, con codici ICD-10 e ATC.

Area	Domanda analitica
Executive Overview	Qual è lo stato complessivo del business?
No-Show Analysis	Dove e come si concentrano le mancate presentazioni?
Business & Revenue Insights	Quali specialità e territori generano più valore?
Patient Analysis	Quali segmenti hanno maggiore valore e rischio?

La logica segue un percorso progressivo: descrizione, segmentazione, individuazione dei driver e lettura strategica. In questo modo Power BI non è solo uno strumento di visualizzazione, ma diventa il livello di comunicazione decisionale dell'analisi.

2. Dashboard — Executive Overview

La Executive Overview sintetizza dimensione economica e operativa. Il fatturato incassato è €25,41 milioni, a fronte di 300.000 appuntamenti complessivi e un no-show rate del 7%. Il reminder coverage raggiunge il 75%, mostrando che la piattaforma dispone già di un meccanismo di prevenzione delle assenze su una quota ampia degli appuntamenti.

Andamento temporale

I dati SQL sulle visite completate mostrano 86.312 visite nel 2023, 86.193 nel 2024 e 86.863 nel 2025, con fatturato rispettivamente di €9,43 M, €9,39 M e €9,45 M. Il business appare stabile nel triennio, senza una crescita esplosiva ma anche senza una contrazione strutturale.

- Il problema principale non è la scala, ma l'ottimizzazione del volume già presente.
- Il 7% di no-show costituisce una quota abbastanza rilevante da giustificare interventi dedicati.
- Il 75% di reminder coverage offre una base concreta per sperimentare un targeting più efficace.

Implicazione manageriale

La priorità è aumentare l'efficienza del volume esistente: ridurre appuntamenti persi e migliorare il valore generato per utente.

3. Dashboard — No-Show Analysis

Questa dashboard individua il principale driver operativo. Il no-show complessivo è 7%, ma la distribuzione varia per età e reminder.

Segmento	No-show rate
Under 30	7,86%
30-44	6,93%
45-59	6,63%
60+	6,49%
Senza reminder	10,12%
Con reminder	5,96%

Il ruolo dei reminder

Il confronto 10,12% contro 5,96% mostra una differenza di circa 4,2 punti percentuali e una riduzione relativa del no-show di circa il 41% tra gli appuntamenti con reminder e quelli senza. Poiché il dataset è simulato e il confronto è osservazionale, il risultato va interpretato come evidenza associativa e non come prova causale definitiva.

Gli under 30 sono il segmento più esposto (7,86%), mentre gli over 60 sono al 6,49%. Per specialità, i valori più elevati sono Ginecologia (7,21%), Endocrinologia (7,20%) e Ortopedia (7,16%). Per giorno della settimana le differenze sono contenute, dal 6,86% del sabato al 7,11% del mercoledì.

Opportunità prioritaria

Passare da un reminder generalizzato a una strategia risk-based: maggiore intensità per i segmenti a rischio, soprattutto pazienti giovani e appuntamenti senza reminder.

4. Dashboard — Business & Revenue Insights

Il fatturato è concentrato in alcune specialità e soprattutto nella città di Roma.

Specialità	Fatturato incassato
Ortopedia	€2,9 M
Ginecologia	€2,6 M

Otorinolaringoiatria	€2,5 M
Neurologia	€2,5 M
Cardiologia	€2,4 M
Medicina Generale	€1,1 M

Concentrazione geografica

Roma genera circa €17,3 milioni, contro €3,1 M a Rieti, €2,0 M a Latina, €1,5 M a Frosinone e €1,5 M a Viterbo. La concentrazione è coerente con il peso della capitale, ma indica sia dipendenza territoriale sia un possibile spazio di crescita nelle altre aree.

Tipo di assicurazione

Il prezzo medio è molto simile tra SSN (€109,49), out-of-pocket (€109,06) e insurance (€109,00). Nel dataset simulato il tipo di copertura non emerge quindi come driver rilevante del prezzo medio.

Implicazione manageriale

Proteggere le specialità ad alto valore e sviluppare progressivamente le aree territoriali meno mature, riducendo la dipendenza da Roma.

5. Dashboard — Patient Analysis

La segmentazione mostra 53,4% di pazienti Medium Frequency, 44,6% Low Frequency e 2,0% High Frequency. Il segmento High Frequency è piccolo ma rappresenta circa €1 M di fatturato incassato; Medium Frequency circa €17 M e Low Frequency circa €7 M.

Top patients e rischio

La tabella mostra utenti con 11–17 visite e spesa individuale superiore a €2.100 nei casi esposti. Alcuni combinano elevato valore e rischio: il patient 6550 ha 17 visite e 23,53% di no-show, mentre il patient 29189 ha 11 visite e 18,18%. Sono casi particolarmente interessanti per una gestione prioritaria.

Attenzione alla metrica Total

La riga Total del visual riporta €32,73 M e 300.000 visite. Questo valore non va confuso con €25,41 M di fatturato incassato: il visual paziente utilizza un perimetro economico differente. Nel documento il KPI ufficiale di ricavo resta pertanto il Fatturato Incassato.

Implicazione manageriale

Utilizzare una gestione differenziata: retention per utenti ad alto valore, riattivazione dei low-frequency users e reminder più intensivi per pazienti ad alto valore e alto rischio.

6. Sintesi trasversale degli insight

Insight	Evidenza	Azione
No-show	7%; 10,12% senza reminder	Aumentare coverage e targeting
Reminder	5,96% con vs 10,12% senza	Strategia risk-based e test controllati
Territorio	Roma ~€17,3 M	Sviluppo mirato delle province
Specialità	Ortopedia ~€2,9 M	Proteggere capacità delle aree ad alto

		valore
Segmentazione	2% High Frequency	Retention e continuità
Pazienti a rischio	Top users con no-show fino a 23,53%	Priorità su reminder e gestione agenda

7. Raccomandazioni strategiche

1. Ottimizzare i reminder

Aumentare la copertura e assegnare maggiore intensità ai pazienti con probabilità di no-show più alta.

2. Introdurre una logica di priorità

Combinare frequenza visite, storico no-show, età e valore economico per identificare i casi più critici.

3. Proteggere i segmenti ad alto valore

Costruire iniziative di retention e continuità per pazienti High Frequency e utenti ad alta spesa.

4. Sviluppare i territori

Analizzare il potenziale di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti per individuare domanda e capacità non pienamente sfruttate.

5. Monitorare la marginalità

Aggiungere costi provider, costi struttura e margine per prestazione in una fase successiva.

6. Evolvere verso la predictive analytics

Costruire un modello di probabilità di no-show e integrarlo in Power BI per il targeting dei reminder.

8. Evoluzione analitica del progetto

Le analisi descrittive rispondono a 'cosa sta succedendo?', mentre segmentazione e no-show iniziano a rispondere a 'dove intervenire?'. Il passo successivo sarebbe un modello supervisionato di probabilità di no-show, validato su dati temporali e valutato per precision, recall, calibrazione e impatto economico.

Next step

Un KPI particolarmente utile sarebbe Expected Lost Revenue = probabilità di no-show × valore della prestazione. Consentirebbe di ordinare gli appuntamenti per valore economico atteso a rischio, non solo per probabilità di assenza.

9. Conclusioni finali

Il report rappresenta una piattaforma sanitaria digitale simulata con 50.000 pazienti, 300.000 appuntamenti e €25,41 milioni di fatturato incassato. Il quadro è positivo, ma la lettura combinata delle dashboard evidenzia tre aree prioritarie: efficienza degli appuntamenti, concentrazione del business e gestione differenziata dei pazienti.

Il no-show del 7% è la principale inefficienza osservabile. Il gap tra reminder e assenza di reminder rende il processo di comunicazione una leva immediatamente azionabile. Parallelamente, Roma e le specialità ad alto valore concentrano una quota importante del business, mentre il segmento High Frequency, pur piccolo, merita una gestione specifica.

Il valore del progetto, dal punto di vista Data Analysis, risiede nel collegamento tra KPI economici, comportamento degli utenti e processi operativi. Power BI viene utilizzato per trasformare i dati in una narrazione decisionale: identificare il fenomeno, quantificarlo, segmentarlo e tradurre l'evidenza in possibili azioni.

Executive takeaway

Trasformare la gestione degli appuntamenti da reattiva a predittiva: identificare in anticipo i pazienti e gli appuntamenti più esposti al no-show, proteggere il valore economico a rischio e usare i dati per orientare crescita e allocazione delle risorse.

Appendice — Perimetro dati

Tabella	Record
patients	50.000
clinics	50
providers	400
appointments	300.000
diagnoses	259.368
medications	90.922
billing	259.368
lab_results	64.753
feedback	46.751

I dati sono sintetici e non rappresentano persone reali. ICD-10 e ATC sono utilizzati come codifiche di riferimento per rendere la struttura del dataset più realistica; le osservazioni restano comunque simulazioni.